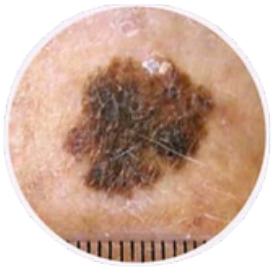
MELANOMA

DR. PABLO DURAN

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

- Representa el 3% de los cánceres de piel, pero es el más común entre los 20 y 30 años; su incidencia ha crecido 81% en los últimos 20 años.
- Exposición solar: 5 quemaduras de niño, o una con ampolla, duplica el riesgo; las camas de bronceado también aumentan el riesgo.
- Factores genéticos (5-10%): xerodermia pigmentosa, nevus pigmentados gigantes, melanoma previo, historia familiar, síndrome FAMM (mutación en CDKN2A), mutaciones en BAP1 y MITF.
- Otros factores: inmunosupresión (trasplante de órgano, linfoma) y nevus displásico.



Melanoma

DIAGNÓSTICO

- Métodos: dermatoscopia, fotografía seriada, biopsia excisional (estándar de oro), biopsia tipo punch o por afeitado.
- Inmunohistoquímica: S100, HMB45, Melan-A.
- Clasificación: extensión superficial (70%, el más frecuente), nodular (el más agresivo), lentigo maligno, acral lentiginoso, mucoso y amelanótico.

PREVENCIÓN Y REGLA ABCDE

- Regla ABCDE: Asimetría, Bordes irregulares, Color variable, Diámetro mayor a 6mm, Evolución o cambio de la lesión.
- La protección solar desde la infancia y evitar las camas de bronceado son las medidas de prevención más efectivas.



ESTADIFICACIÓN Y PRONÓSTICO

- Biología: se origina en los melanocitos; puede crecer de forma radial o vertical; lo más importante para el TNM es la biopsia incisional.
- Niveles de Clark y Breslow: miden la profundidad de invasión, claves para la estadificación TNM.
- Factores pronósticos: ulceración, índice mitótico, infiltrado linfocítico, metástasis a ganglios linfáticos, invasión neural, número de metástasis.
- Estudios de extensión: PET-CT, TC y RM según el estadio.

TRATAMIENTO

- Cirugía: resección con bordes amplios según el grosor de Breslow; cirugía de Mohs en casos seleccionados.
- Biopsia del ganglio centinela: si es positivo, se plantea inmunoterapia; si es negativo, observación. Ya no se hace disección ganglionar completa de rutina.
- Melanoma en tránsito: puede tratarse con perfusión de melfalán en la extremidad afectada.
- Inmunoterapia: anti-CTLA-4, anti-PD1 (pembrolizumab, nivolumab), inhibidores de BRAF y MEK; terapia CAR-T en casos avanzados.

MELANOMA METÁSTASICO

- Sitios más frecuentes de metástasis: ganglios linfáticos, piel, pulmón, hígado y cerebro.
- La combinación de inmunoterapia y terapia dirigida mejora significativamente la supervivencia comparado con la quimioterapia tradicional.

MELANOMA

DR. PABLO DURAN

TRATAMIENTO

- Resección amplia con márgenes adecuados.
- Cirugía de Mohs: indicada en zonas de alto riesgo estético o funcional (cara, manos).
- Otras opciones: crioterapia y 5-fluoracilo tópico; la radioterapia ya no se usa tanto, salvo en casos difíciles.

PROFUNDIDAD DE BRESLOW

- Medida microscópica en mm desde el estrato granuloso hasta la célula tumoral más profunda: el factor pronóstico individual más importante.

GANGLIO CENTINELA EN MELANOMA

- Indicado si el Breslow es ≥0,8 mm o hay ulceración.

INMUNOTERAPIA

- Anti-PD-1 (pembrolizumab, nivolumab) y anti-CTLA-4 (ipilimumab).

TERAPIA DIRIGIDA

- Inhibidores de BRAF V600E (dabrafenib, vemurafenib), mutación presente en el 50–75%.

MÁRGENES QUIRÚRGICOS

- In situ: 0,5 cm. Breslow ≤1 mm: 1 cm. Breslow >2 mm: 2 cm.

CLASIFICACIÓN DE BRESLOW Y CLARK MELANOMAS

